

Briefing de Figuras — Capítulo 7

"A: Alimentação, Atividade Física e Suplementação — Os Três Motores"

DIRETRIZES GERAIS

Seguir a paleta e tipografia já definidas nos briefings dos capítulos anteriores:

- Verde escuro (#2D6A4F): zona ótima / segura
 - Amarelo-âmbar (#E9C46A): zona de alerta / subótima
 - Vermelho suave (#E76F51): zona de risco / alto risco
 - Cinza médio (#8D99AE): referência / comparação
 - Azul escuro / grafite (#264653): dados do paciente / destaque principal
 - Fundo: branco ou off-white (#FAFAFA)
 - Tipografia: sans-serif limpa (Inter, Source Sans Pro ou similar). Títulos 14–16pt bold, rótulos 10–12pt regular.
 - Formato: vetor (SVG ou AI) + PNG alta resolução (300 dpi, mínimo 2000px largura).
-

FIGURA 1 — "O Fator de Risco que Ninguém Prescreve"

Objetivo comunicacional

Mostrar visualmente que a baixa aptidão cardiorrespiratória é o fator de risco mais letal entre todos os preditores tradicionais de mortalidade — e que a diferença não é marginal: é de 5 vezes. O leitor deve olhar para esta figura e pensar: "Espera — ser sedentário é PIOR que fumar?"

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: "*Aptidão cardiorrespiratória*

baixa era, literalmente, o fator de risco mais letal da lista — e o mais modificável.”

Tipo de gráfico

Gráfico de barras horizontais — uma barra por fator de risco, ordenadas de maior para menor HR.

Dados a representar (Mandsager et al., JAMA Network Open, 2018)

Fator de risco	HR ajustado (vs. referência)
Aptidão cardiorrespiratória baixa (vs. elite)	5,04
Doença renal crônica terminal	1,98
Tabagismo	1,41
Diabetes	1,40
Doença coronariana	1,29

Estrutura visual

Layout: 5 barras horizontais empilhadas verticalmente, ordenadas de cima para baixo pela magnitude do HR (5,04 no topo, 1,29 na base).

Cores das barras:

- Barra de aptidão baixa: **vermelho (#E76F51)** — cor de alarme, destaque visual máximo. Visivelmente mais longa que todas as outras.
- Barras de tabagismo, diabetes, doença coronariana e DRC: **cinza médio (#8D99AE)** — fatores de risco “conhecidos”, segundo plano visual.

Linha de referência: Uma linha vertical tracejada fina em HR = 1,0 (risco de referência), com rótulo discreto: “Referência (grupo elite / sem o fator de risco)”.

Rótulos: À esquerda de cada barra, o nome do fator de risco. À direita de cada barra (ou dentro, se houver espaço), o valor do HR (ex: “5,04x”, “1,41x”).

Elemento-chave: A diferença visual de comprimento entre a barra vermelha (5,04) e as barras cinzas (~1,3–1,9) deve ser imediatamente impactante. A barra do sedentarismo é ~3,5 vezes mais longa que a do tabagismo. Essa proporção visual É a mensagem.

Título da figura

"Aptidão cardiorrespiratória baixa: o fator de risco mais letal — e o mais ignorado"

Legenda/nota de rodapé

"Hazard ratio ajustado para mortalidade por todas as causas. Dados de 122.007 adultos acompanhados por mediana de 8,4 anos (Mandsager et al., JAMA Network Open, 2018). Aptidão baixa definida como abaixo do percentil 25 para idade e sexo. Referência: grupo elite (acima do percentil 97,7)."

O que NÃO fazer

- Não usar gráfico de barras verticais (horizontais facilitam a leitura comparativa de rótulos longos)
 - Não incluir intervalos de confiança (poluição visual desnecessária para o público leigo; os HRs são todos estatisticamente significativos)
 - Não usar ícones decorativos (nada de ícone de pulmão para tabagismo, coração para doença coronariana, etc.)
 - Não incluir os grupos intermediários (acima da média, alta) — o contraste relevante é entre o extremo baixo e os fatores de risco clássicos
-

FIGURA 2 — "O Primeiro Degrau É o que Mais Conta"

Objetivo comunicacional

Mostrar a curva dose-resposta entre aptidão cardiorrespiratória e mortalidade — especificamente, que o salto mais dramático de benefício ocorre ao sair do grupo mais sedentário para o seguinte. O leitor deve olhar e entender: "Não preciso ser atleta. Preciso sair do sofá."

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: *"A notícia é ao mesmo tempo perturbadora e libertadora: perturbadora porque o sedentarismo carrega risco comparável ao tabagismo; libertadora porque começar já muda o jogo."*

Tipo de gráfico

Gráfico de linha com pontos marcados — eixo X com os 5 grupos de aptidão, eixo Y com risco relativo de mortalidade. A linha desce da esquerda para a direita, com queda acentuada no primeiro segmento e achatamento progressivo.

Dados a representar (Mandsager et al., 2018 — invertidos para risco relativo com baixa aptidão como referência)

Grupo de aptidão	HR (referência = elite)	Risco relativo (referência = baixa)
Baixa (<P25)	5,04	1,00 (referência)
Abaixo da média (P25–P49)	~2,10	0,42
Acima da média (P50–P74)	~1,49	0,30
Alta (P75–P97,6)	~1,29	0,26
Elite (≥P97,7)	1,00	0,20

Nota para o designer: os valores intermediários são estimativas derivadas dos HRs publicados no estudo. Os pontos extremos (5,04 e 1,00) são exatos.

Estrutura visual

Eixo X (horizontal): 5 posições igualmente espaçadas, rotuladas: "Baixa", "Abaixo da média", "Acima da média", "Alta", "Elite".

Eixo Y (vertical): Risco relativo de mortalidade (escala de 0 a 1,0 se usar baixa como referência, ou HR de 1,0 a 5,5 se usar elite como referência). A segunda opção é mais intuitiva: o leitor vê o risco caindo.

Linha de dados: cor azul escuro (#264653), espessura 2,5pt, com pontos marcados (círculos 8pt).

Zona de destaque: sombrear com verde claro a área entre o primeiro ponto (Baixa) e o segundo (Abaixo da média) — é o segmento onde a queda é mais acentuada. Adicionar uma anotação: "**Maior ganho: sair do sedentarismo**" com uma seta apontando para esse segmento.

Zona de referência: uma faixa horizontal tracejada fina indicando o nível de risco associado ao tabagismo (HR ~1,41), para que o leitor veja onde o risco do sedentarismo cruza o risco de fumar.

Título da figura

"O maior retorno sobre o investimento está no primeiro passo"

Legenda/nota de rodapé

“Risco ajustado de mortalidade por todas as causas em função da aptidão cardiorrespiratória, estratificada em cinco grupos por percentil (Mandsager et al., 2018). A queda mais acentuada ocorre entre o grupo de menor aptidão e o seguinte — equivalente a seguir as diretrizes básicas de 150 minutos semanais de atividade moderada.”

O que NÃO fazer

- Não usar gráfico de barras (a mensagem é sobre curva/tendência, não comparação estática)
 - Não omitir os grupos intermediários (desta vez, diferente da Figura 1, todos os 5 grupos são necessários para mostrar o formato da curva)
 - Não usar escala logarítmica (dificultaria a percepção visual da queda acentuada no primeiro segmento)
 - Não adicionar dados de outros estudos — manter a fonte única para clareza
-

FIGURA 3 — “Marcos: 8 Meses Depois”

Objetivo comunicacional

Mostrar visualmente a transformação dos biomarcadores de Marcos entre a consulta do Capítulo 5 (linha de base) e a reavaliação 8 meses depois, com os três motores funcionando. O leitor deve ver setas se movendo da zona subótima para a zona ótima — e entender que essa mudança foi produzida por alimentação, exercício e suplementação em conjunto com a medicação.

Esta figura funciona como espelho da Figura 2 do Capítulo 1 (os números de Ricardo “todos normais, nenhum ótimo”). No Cap 1, os pontos estavam parados na zona subótima. Aqui, eles se movem.

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: *“1,8 MET equivale a algo entre 25% e 30% de redução adicional no risco de morte — um ganho que nenhum ajuste farmacológico teria produzido sozinho.”*

Tipo de gráfico

Dot plot horizontal com setas de movimento — mesmo layout da Figura 2 do Cap 1, mas

com dois pontos por linha (antes e depois) conectados por uma seta.

Dados a representar

Biomarcador	Antes (Cap 5)	Depois (8 meses)	Alvo ótimo	Limite "normal" lab	Unidade
Insulina de jejum	11	6	< 8	25	μIU/mL
hs-CRP	1,6	0,6	< 1,0	3,0	mg/L
ApoB	82	58	< 70	130	mg/dL
Vitamina D	28	52	40–60	> 20	ng/mL
VO ₂ max (METs)	basal	+1,8 MET	—	—	MET

Estrutura visual

Layout: 5 linhas horizontais empilhadas (uma por biomarcador), mesmo formato da Figura 2 do Cap 1.

Zonas de fundo em cada linha:

- **Verde** à esquerda: zona ótima
- **Amarelo** no meio: zona subótima
- **Branco/cinza claro** à direita: zona "normal" do lab

Marcadores em cada linha:

- **Círculo vermelho semitransparente (○):** valor ANTES (Cap 5)
- **Círculo azul escuro preenchido (●):** valor DEPOIS (8 meses)
- **Seta** conectando os dois pontos: direção do movimento (da zona subótima para a zona ótima)
- **Triângulo verde (▲):** posição do alvo ótimo
- **Linha tracejada cinza:** limite de normalidade do lab

Para a linha de VO₂ max: usar uma barra de progresso simples mostrando +1,8 MET, com anotação: "+25–30% de redução no risco de morte".

Resultado visual esperado: Em 4 das 5 linhas, a seta se move da zona amarela (subótima) para a zona verde (ótima). Na linha do ApoB, a seta cruza o alvo ótimo — o ponto de 58 está além do alvo de 70 (resultado excelente). O padrão visual de setas convergindo para o verde é a mensagem: a trajetória mudou.

Título da figura

“Os três motores em ação: 8 meses que mudaram a trajetória de Marcos”

Legenda/nota de rodapé

“Em vermelho, valores de Marcos na consulta inicial (Capítulo 5). Em azul, valores 8 meses depois com alimentação, exercício e suplementação estruturados — além da terapia farmacológica (estatina + ezetimiba). As setas mostram a direção da mudança. O triângulo verde marca o alvo ótimo para longevidade.”

O que NÃO fazer

- Não usar gráfico de barras comparativas (o layout de dot plot com setas preserva a linguagem visual do Cap 1 e cria continuidade no livro)
- Não incluir mais de 5 biomarcadores (os mesmos critérios do Cap 1: clareza visual)
- Não usar escala unificada (cada biomarcador tem unidade e faixa próprias)
- Não omitir o limite do laboratório (manter o contraste “normal vs. ótimo” que é o fio condutor visual do livro)
- Não incluir composição corporal (5 kg gordura / 2 kg massa magra) como linha separada — mencionar na legenda se necessário, mas o gráfico deve focar nos marcadores sanguíneos + VO₂ max

O QUE NÃO INCLUIR NESTE CAPÍTULO

- **Template visual de semana de treino:** as tabelas no texto já cumprem essa função. Transformá-las em infográfico acrescentaria pouco e correria o risco de parecer material de academia, não de livro médico. Se no futuro quiser uma versão “destacável” para impressão, pode ser adicionada como apêndice — não como figura no corpo do capítulo.
- **Diagrama dos 4 pilares do exercício:** o texto explica com clareza suficiente. Um diagrama com 4 caixas e ícones seria genérico e quebraria o tom clínico. A informação já está estruturada com subtítulos em bold.

- **Pirâmide alimentar ou prato saudável:** clichê visual que contradiz o tom do capítulo (“Não é dieta — é estratégia metabólica”). Evitar qualquer imagem que remeta a material de nutricionista genérico.
- **Fotos de alimentos, suplementos ou exercícios:** stock art. Não acrescenta.

NOTA SOBRE CONTINUIDADE VISUAL

A Figura 3 deste capítulo é o **espelho narrativo** da Figura 2 do Capítulo 1:

	Cap 1 — Figura 2	Cap 7 — Figura 3
Paciente	Ricardo	Marcos
Momento	Diagnóstico (pontos parados)	Follow-up (pontos em movimento)
Mensagem	“Todos normais. Nenhum ótimo.”	“A trajetória mudou.”
Layout	Dot plot horizontal com 3 marcadores por linha	Mesmo layout + setas de movimento

Esse espelhamento visual fecha o arco do livro até aqui: no Cap 1, o leitor viu o problema (biomarcadores estagnados na zona subótima). No Cap 7, vê a solução em ação (biomarcadores migrando para a zona ótima). A linguagem visual deve ser idêntica para que o leitor reconheça a conexão sem precisar que alguém explique.